QUY TRÌNH BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH GIỮA CÁC KHOA/ĐƠN VỊ

Áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân

Bản trình thẩm định năm 2026 — rà soát ngày 13/10/2026

Nội dung	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên			
Chức danh			
Chữ ký			
Ngày			

BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Lần sửa đổi	Ngày	Nội dung sửa đổi	Người thực hiện	Phê duyệt
Dự thảo 2026	13/10/2026	Điền tên Nhật Tân; bổ sung QĐ 3023 và TT13; làm rõ ngoại lệ cấp cứu, nhận diện, thuốc hỗ trợ sống; chỉnh cách tính chỉ số.	Phòng Điều dưỡng xác nhận	Chờ thẩm định

NGUYÊN TẮC AN TOÀN CỐT LÕI

Bàn giao người bệnh là quá trình chuyển đồng thời trách nhiệm chăm sóc, thông tin lâm sàng, hồ sơ, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị đi kèm và các vấn đề cần tiếp tục theo dõi từ đơn vị giao sang đơn vị nhận.

Mỗi lần bàn giao phải xác nhận người bệnh bằng ít nhất hai thông tin nhận diện; không sử dụng số phòng hoặc số giường làm thông tin nhận diện duy nhất.

Áp dụng giao tiếp có cấu trúc SBAR, bàn giao trực tiếp đối với nội dung nguy cơ cao và tạo cơ hội để người nhận hỏi, đọc lại hoặc nhắc lại thông tin trọng yếu.

Không vận chuyển người bệnh khi khoa nhận chưa xác nhận sẵn sàng, trừ cấp cứu đe dọa tính mạng; khi đó phải kích hoạt phối hợp khẩn cấp và thông báo trên đường chuyển.

Người bệnh không ổn định chỉ được chuyển sau khi đánh giá lợi ích - nguy cơ, ổn định tối đa có thể và chuẩn bị nhân lực, thiết bị, thuốc cấp cứu phù hợp.

Bàn giao chưa hoàn tất nếu người nhận chưa đánh giá ban đầu, chưa xác nhận tiếp nhận hoặc còn nội dung trọng yếu chưa được làm rõ.

Không trì hoãn cấp cứu vì thủ tục giấy tờ; hồ sơ còn thiếu phải được ghi nhận, giao nhiệm vụ bổ sung và có thời hạn.

Thông tin chỉ được trao đổi trong phạm vi cần thiết cho chăm sóc an toàn, bảo đảm riêng tư và bảo mật.

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Định nghĩa

Bàn giao người bệnh giữa các khoa/đơn vị là quá trình có cấu trúc trong đó cá nhân hoặc nhóm chăm sóc chuyển quyền và trách nhiệm chăm sóc người bệnh cho cá nhân hoặc nhóm khác trong cùng bệnh viện, kèm theo thông tin, hồ sơ, thuốc, dịch truyền, mẫu bệnh phẩm, tài sản và các phương tiện hỗ trợ cần thiết để bảo đảm chăm sóc liên tục và an toàn.

1.2. Nguyên lý

Chuyển người bệnh là một điểm chuyển tiếp có nguy cơ cao; giao tiếp thiếu hoặc hiểu sai có thể làm gián đoạn chăm sóc, bỏ sót thuốc, xét nghiệm, cảnh báo hoặc can thiệp cần tiếp tục.

Bàn giao phải được chuẩn hóa nhưng vẫn điều chỉnh theo mức độ nặng, chuyên khoa, phương tiện vận chuyển và tình trạng khẩn cấp.

Kết hợp hồ sơ bằng văn bản/điện tử với trao đổi trực tiếp; không chỉ gửi hồ sơ hoặc nhắn tin thay cho bàn giao chuyên môn đối với người bệnh nguy cơ cao.

Khoa giao chịu trách nhiệm đánh giá, chuẩn bị và chăm sóc cho đến khi khoa nhận chính thức tiếp nhận; khoa nhận chịu trách nhiệm từ thời điểm xác nhận bàn giao.

Thông tin trọng yếu được trình bày theo SBAR: S - tình huống hiện tại; B - thông tin nền liên quan; A - nhận định/đánh giá; R - khuyến nghị và việc cần tiếp tục.

Người bệnh và người đại diện được thông báo về lý do chuyển, nơi đến và bước chăm sóc tiếp theo ở mức phù hợp.

1.3. Mục đích

Bảo đảm đúng người bệnh, đúng khoa nhận, đúng thời điểm và đúng mức hỗ trợ vận chuyển.

Chuyển giao đầy đủ tình trạng, diễn biến, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, nguy cơ và kế hoạch tiếp theo.

Phòng ngừa bỏ sót thuốc, dị ứng, kết quả xét nghiệm, chỉ định, đường truyền, dẫn lưu, thiết bị và chế độ cách ly.

Xác định rõ người giao, người nhận, thời điểm chuyển trách nhiệm và nội dung còn tồn đọng.

Duy trì an toàn người bệnh trong quá trình vận chuyển và ngay sau tiếp nhận.

Tạo dữ liệu giám sát chất lượng, sự cố và cải tiến hoạt động bàn giao.

1.4. Phạm vi

Từ Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu hoặc đơn vị tiếp nhận vào khoa nội trú.

Chuyển giữa các khoa lâm sàng, giữa khoa thường và hồi sức/cấp cứu.

Chuyển đến và từ Phòng mổ, Hồi tỉnh, khu thủ thuật, nội soi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm hoặc phục hồi chức năng.

Chuyển người bệnh cách ly, trẻ sơ sinh/trẻ em, sản phụ, người bệnh có rối loạn hành vi hoặc nguy cơ an ninh.

Chuyển tạm thời để thực hiện kỹ thuật và bàn giao lại khoa điều trị.

Chuyển viện và ra viện thực hiện theo quy trình chuyên biệt nhưng sử dụng các nguyên tắc bàn giao có cấu trúc trong tài liệu này.

2. CHỈ ĐỊNH

Có quyết định nhập viện và giường/khoa tiếp nhận phù hợp.

Có chỉ định chuyển khoa do thay đổi chẩn đoán, mức độ nặng, nhu cầu chuyên môn hoặc khả năng chăm sóc.

Cần chuyển đến hồi sức, cấp cứu, phẫu thuật, thủ thuật hoặc kỹ thuật chẩn đoán/điều trị.

Hoàn tất can thiệp tại đơn vị chuyên môn và đủ điều kiện trở về khoa điều trị hoặc chuyển khoa khác.

Có yêu cầu cách ly, giám sát đặc biệt, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ hoặc điều kiện chuyên khoa.

Điều phối giường bệnh, tổ chức lại khu điều trị hoặc tình huống dịch bệnh/khẩn cấp theo quyết định có thẩm quyền.

Người bệnh được chuyển trong nội bộ cơ sở vì yêu cầu an toàn, an ninh hoặc cơ sở vật chất.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không thực hiện chuyển theo quy trình thông thường khi người bệnh đang ngừng tuần hoàn, ngừng thở hoặc cần can thiệp cứu sống tại chỗ; chỉ chuyển khi đội cấp cứu quyết định và có phương án hồi sức liên tục.

Người bệnh chưa được đánh giá khả năng chịu đựng vận chuyển hoặc chưa ổn định tối đa có thể, trừ khi lợi ích của chuyển khẩn cấp vượt nguy cơ.

Khoa nhận chưa đồng ý tiếp nhận, chưa có giường/điều kiện phù hợp hoặc chưa bố trí nhân lực, trừ tình huống khẩn cấp được lãnh đạo điều phối.

Thông tin nhận diện chưa xác minh hoặc không khớp: tạm dừng chuyển thông thường để đối chiếu và khắc phục. Trường hợp cấp cứu chưa rõ danh tính, dùng mã nhận diện tạm thời duy nhất theo quy định bệnh viện, duy trì cấp cứu và bàn giao rõ tình trạng chưa xác minh; không trì hoãn xử trí cứu sống.

Thiếu thiết bị, oxy, thuốc, nhân lực hộ tống hoặc phương tiện vận chuyển cần thiết cho mức nguy cơ.

Đường thở, đường truyền, dẫn lưu, băng cố định hoặc thiết bị chưa được kiểm tra và bảo đảm an toàn.

Không xác định chế độ cách ly hoặc tuyến vận chuyển đối với người bệnh có nguy cơ lây nhiễm.

Hồ sơ/chỉ định trọng yếu chưa được làm rõ và việc thiếu đó có thể gây nguy hại ngay sau chuyển.

Phương tiện vận chuyển hỏng, không khóa được, không có lan can hoặc không phù hợp tình trạng người bệnh.

4. THẬN TRỌNG

Không dùng số giường, phòng hoặc vị trí làm thông tin nhận diện duy nhất.

Không chuyển người bệnh chỉ với nhân viên vận chuyển khi người bệnh cần theo dõi chuyên môn, oxy, truyền dịch, bơm tiêm điện, nguy cơ co giật, té ngã hoặc diễn biến nhanh.

Không ngắt oxy, thuốc vận mạch, truyền máu, thuốc đang truyền hoặc thiết bị hỗ trợ sống nếu chưa có chỉ định và phương án thay thế an toàn.

Kiểm tra thời lượng pin, lượng oxy và thể tích thuốc/dịch đủ cho thời gian dự kiến cộng dự phòng.

Đường truyền, ống nội khí quản, mở khí quản, catheter, dẫn lưu, sonde và thiết bị phải được cố định, đánh dấu và kiểm đếm.

Không đặt hồ sơ, thuốc hoặc mẫu bệnh phẩm rời trên giường dễ thất lạc; dùng túi/hộp có nhận diện.

Bàn giao nội dung nhạy cảm tại nơi bảo đảm riêng tư; không trao đổi to tiếng ở hành lang hoặc khu đông người.

Người bệnh có nguy cơ ngã phải có lan can, dây đai khi phù hợp và nhân lực hỗ trợ chuyển tư thế.

Người bệnh có kích động, nguy cơ tự gây hại hoặc bạo lực cần kế hoạch an ninh, nhân lực và biện pháp hạn chế phù hợp quy định; không vận chuyển đơn độc.

Trẻ sơ sinh phải đối chiếu vòng nhận diện với mẹ/hồ sơ; người bệnh không giao tiếp được cần đối chiếu vòng, hồ sơ và người đại diện.

Người bệnh cách ly phải tuân thủ PPE, khẩu trang, tuyến đường, vệ sinh phương tiện và thông báo trước cho khoa nhận.

Kết quả xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh chưa trả phải có người chịu trách nhiệm theo dõi và cách thức thông báo sau bàn giao.

Mọi thay đổi tình trạng sau khi báo khoa nhận nhưng trước khi rời khoa phải được cập nhật lại.

Trong bàn giao khẩn cấp, ưu tiên thông tin cứu sống trước; nội dung còn lại bổ sung ngay khi người bệnh ổn định.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ khoa giao: quyết định/đề xuất chuyển, đánh giá ổn định, chỉ định hỗ trợ và trao đổi với bác sĩ khoa nhận khi cần.

Điều dưỡng/hộ sinh khoa giao: chuẩn bị người bệnh, hồ sơ, thuốc, thiết bị, biểu mẫu và thực hiện bàn giao điều dưỡng.

Bác sĩ khoa nhận: xác nhận tiếp nhận người bệnh nguy cơ cao, làm rõ kế hoạch điều trị và xử trí ngay khi đến.

Điều dưỡng/hộ sinh khoa nhận: xác nhận giường, thiết bị, tiếp nhận SBAR, đánh giá ban đầu và ký nhận.

Nhân viên hộ tống: bác sĩ, điều dưỡng/hộ sinh, kỹ thuật viên hoặc nhân viên vận chuyển theo phân tầng nguy cơ.

Hộ lý/nhân viên vận chuyển: chuẩn bị phương tiện, hỗ trợ vận chuyển theo phân công; không thay thế người hộ tống chuyên môn.

Điều dưỡng trưởng/trực lãnh đạo: điều phối khi thiếu giường, bất đồng tiếp nhận, nguy cơ cao hoặc tình huống khẩn.

5.2. Thuốc

Thuốc đang sử dụng hoặc cần dùng trong vận chuyển theo y lệnh.

Thuốc cấp cứu phù hợp nguy cơ và phạm vi chuyên môn của đội hộ tống.

Thuốc cá nhân của người bệnh được kiểm kê, niêm phong và bàn giao theo quy định.

Thuốc gây nghiện, hướng thần, thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc lạnh thực hiện bàn giao riêng theo quy định dược.

Không mang theo thuốc không nhãn, không rõ người bệnh, đã hết hạn hoặc không có chỉ định.

5.3. Vật tư

Phiếu bàn giao SBAR, bảng kiểm trước chuyển và phiếu ký nhận.

Vòng/nhãn nhận diện còn rõ; nhãn cảnh báo dị ứng, nguy cơ ngã hoặc cách ly theo quy định.

Oxy, dây thở, bóng bóp, mặt nạ, dụng cụ hút và vật tư cấp cứu tùy nguy cơ.

Băng cố định đường truyền, dẫn lưu, catheter và thiết bị.

Túi/hộp đựng hồ sơ, thuốc, mẫu bệnh phẩm và tài sản có nhận diện.

PPE và vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn.

Chăn, ga, tã hoặc phương tiện bảo đảm kín đáo và thân nhiệt.

5.4. Trang thiết bị

Giường, cáng hoặc xe lăn phù hợp, có phanh, lan can và dây đai khi cần.

Máy theo dõi, máy đo huyết áp, SpO2, máy thở vận chuyển, bơm tiêm điện hoặc máy truyền dịch theo nguy cơ.

Nguồn oxy đủ thời gian và có dự phòng.

Thiết bị liên lạc với khoa giao, khoa nhận và đội cấp cứu.

Phương tiện vận chuyển trẻ sơ sinh, sản phụ, người bệnh béo hoặc cách ly theo yêu cầu chuyên khoa.

Thiết bị phải được kiểm tra chức năng, pin, dây nối và vệ sinh trước sử dụng.

5.5. Người bệnh

Xác nhận ít nhất hai thông tin nhận diện.

Đánh giá tình trạng hiện tại, dấu hiệu sinh tồn, tri giác, đau, đường thở, hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến.

Phân cấp chăm sóc và phân tầng nguy cơ vận chuyển.

Giải thích lý do chuyển, khoa đến, phương tiện và người đi cùng; lấy đồng thuận khi pháp luật/quy định yêu cầu.

Bảo đảm vệ sinh, trang phục, che chắn, tư thế và dự phòng ngã/loét tỳ đè.

Kiểm tra người bệnh đã hoàn tất chuẩn bị đặc biệt: nhịn ăn, dị ứng, cách ly, xét nghiệm, giấy cam kết hoặc chỉ định trước thủ thuật khi áp dụng.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Hồ sơ giấy hoặc điện tử đã cập nhật chẩn đoán, diễn biến, y lệnh, chăm sóc, thuốc và dấu hiệu sinh tồn.

Phiếu chuyển khoa/nhập khoa, chỉ định phẫu thuật/thủ thuật, phiếu gây mê, phiếu hồi tỉnh hoặc phiếu chuyên khoa tương ứng.

Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nhóm máu, vi sinh và kết quả quan trọng.

Danh sách thuốc hiện tại, thuốc đã dùng gần nhất, dị ứng, phản ứng có hại và thuốc cần tiếp tục.

Biên bản hội chẩn, cam kết, chỉ định cách ly, cảnh báo đặc biệt.

Kết quả đang chờ và người chịu trách nhiệm theo dõi.

Phiếu tài sản, tiền, thuốc cá nhân, mẫu bệnh phẩm và thiết bị đi kèm.

5.7. Thời gian thực hiện

Thực hiện ngay khi có quyết định chuyển và khoa nhận xác nhận sẵn sàng. Đối với chuyển cấp cứu, rút gọn thủ tục nhưng không bỏ nhận diện, thông báo nơi nhận, đánh giá nguy cơ, chuẩn bị hỗ trợ sống và bàn giao thông tin cứu sống.

5.8. Địa điểm

Bàn giao chuẩn bị tại giường người bệnh hoặc khu vực chuyên môn bảo đảm riêng tư.

Bàn giao trực tiếp tại khu tiếp nhận của khoa nhận hoặc cạnh giường sau khi chuyển an toàn.

Không bàn giao người bệnh nguy cơ cao chỉ qua điện thoại, tin nhắn hoặc tại hành lang mà không đánh giá trực tiếp.

Phương tiện và tuyến vận chuyển phải được khảo sát khi có rào cản, thang máy, cách ly hoặc cấp cứu.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và điều kiện

Có quyết định/chỉ định chuyển và tên khoa nhận.

Khoa nhận đã xác nhận giường, người nhận và thời điểm.

Hai thông tin nhận diện khớp vòng tay, hồ sơ và người bệnh.

Phân tầng nguy cơ, nhân lực hộ tống và thiết bị phù hợp.

Dấu hiệu sinh tồn và tình trạng mới nhất đã được ghi.

Thuốc, dịch, đường truyền, dẫn lưu, oxy và thiết bị đã kiểm tra.

Hồ sơ, kết quả, tài sản và mẫu bệnh phẩm đã kiểm đếm.

Chế độ cách ly/tuyến vận chuyển đã xác định.

Người bệnh/người đại diện đã được thông báo.

Không còn nội dung trọng yếu chưa làm rõ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1 - Tiếp nhận quyết định chuyển

Xác nhận người ra quyết định, lý do, mức độ khẩn và khoa đến.

Kiểm tra chỉ định chuyển đã ghi trong hồ sơ/y lệnh.

Xác định chuyển vĩnh viễn hay tạm thời để làm kỹ thuật.

Không tự chuyển khoa khi chưa có chỉ định, trừ kích hoạt cấp cứu theo quy định.

6.2. Bước 2 - Liên hệ khoa nhận

Thông báo họ tên, mã người bệnh, chẩn đoán, mức độ nặng, cách ly và nhu cầu thiết bị.

Xác nhận khoa nhận đồng ý, giường/vị trí, người nhận và thời gian.

Người bệnh nguy cơ cao cần trao đổi bác sĩ - bác sĩ và điều dưỡng - điều dưỡng.

Ghi tên người xác nhận và thời điểm liên hệ.

6.3. Bước 3 - Xác nhận đúng người bệnh

Hỏi người bệnh nêu họ tên và ngày sinh/thông tin thứ hai khi có thể.

Đối chiếu vòng nhận diện, hồ sơ và lệnh chuyển.

Người bệnh không giao tiếp: đối chiếu vòng, hồ sơ, người đại diện và hai nhân viên khi cần.

Tạm dừng chuyển thông thường nếu thông tin không khớp, báo người phụ trách và xác minh. Với cấp cứu chưa rõ danh tính, sử dụng mã nhận diện tạm thời duy nhất theo quy định bệnh viện và đối chiếu xuyên suốt; không trì hoãn cấp cứu.

6.4. Bước 4 - Đánh giá tình trạng hiện tại

Đánh giá ABC, tri giác, đau, dấu hiệu sinh tồn, da/niêm mạc và nguy cơ diễn biến.

Ghi thời điểm đánh giá ngay trước chuyển theo quy định nội bộ.

So sánh với tình trạng đã báo khoa nhận.

Có thay đổi đáng kể phải báo lại và xem xét điều chỉnh kế hoạch.

6.5. Bước 5 - Phân tầng nguy cơ vận chuyển

Mức 1 - ổn định: không cần theo dõi liên tục, phương tiện thường, người hộ tống theo đánh giá.

Mức 2 - có nguy cơ: cần điều dưỡng/hộ sinh hộ tống, oxy/monitor hoặc thuốc đang truyền.

Mức 3 - nguy kịch: bác sĩ và điều dưỡng hộ tống, phương tiện hồi sức, theo dõi liên tục và khoa nhận sẵn sàng cấp cứu.

Phân tầng nội bộ phải được bệnh viện phê duyệt và ghi trên phiếu.

6.6. Bước 6 - Ổn định tối đa trước chuyển

Bảo đảm đường thở, hô hấp, tuần hoàn và kiểm soát chảy máu theo y lệnh.

Giảm đau, chống nôn hoặc can thiệp cần thiết theo chỉ định.

Cố định gãy xương, cổ hoặc vùng tổn thương khi áp dụng.

Nếu không thể ổn định nhưng cần chuyển cứu sống, ghi rõ đánh giá lợi ích - nguy cơ.

6.7. Bước 7 - Xác định yêu cầu cách ly và an ninh

Xác định đường lây truyền, PPE, khẩu trang người bệnh, tuyến và phương tiện.

Thông báo khoa nhận và bộ phận vận chuyển trước.

Người bệnh nguy cơ hành vi cần kế hoạch nhân lực/an ninh.

Không công khai chẩn đoán nhạy cảm ngoài phạm vi cần thiết.

6.8. Bước 8 - Đối chiếu thuốc

Lập danh sách thuốc đang dùng, thời điểm liều gần nhất và liều kế tiếp.

Xác định thuốc truyền liên tục, thuốc cấp cứu, thuốc cá nhân và thuốc cần bảo quản đặc biệt.

Làm rõ thuốc tạm ngừng, thay đổi hoặc còn chờ chỉ định.

Sai lệch phải được bác sĩ/dược sĩ làm rõ trước chuyển nếu không trì hoãn cấp cứu.

6.9. Bước 9 - Kiểm tra đường truyền, dẫn lưu và thiết bị

Kiểm đếm từng đường truyền, catheter, sonde, dẫn lưu, ống thở và thiết bị.

Ghi vị trí, loại, ngày đặt khi có, tình trạng, lưu lượng/mức cài đặt và lượng dịch.

Cố định, sắp xếp dây tránh kéo, gập, tuột hoặc nhầm nối.

Dẫn lưu và túi chứa được làm rỗng/đo nếu có chỉ định và phù hợp.

6.10. Bước 10 - Rà soát kết quả và việc còn chờ

Bàn giao kết quả bất thường quan trọng và hành động đã thực hiện.

Liệt kê xét nghiệm/chẩn đoán đang chờ, thời điểm dự kiến và người theo dõi.

Xác định mẫu bệnh phẩm đang mang theo hoặc đã gửi.

Không ghi chung chung 'xem hồ sơ' thay cho thông tin trọng yếu.

6.11. Bước 11 - Chuẩn bị hồ sơ

Cập nhật diễn biến, y lệnh, thuốc, chăm sóc, dấu hiệu sinh tồn và bảng kiểm.

Sắp xếp hồ sơ giấy trong túi kín hoặc bảo đảm hồ sơ điện tử sẵn có.

Kiểm tra chữ ký/xác nhận cần thiết.

Ghi rõ tài liệu chưa có và kế hoạch bổ sung.

6.12. Bước 12 - Chuẩn bị tài sản, thuốc và mẫu bệnh phẩm

Kiểm kê tài sản, tiền, giấy tờ, thuốc cá nhân và đồ dùng.

Niêm phong/ghi nhãn theo quy định và có người nhận.

Mẫu bệnh phẩm đặt trong bao bì chuyên dụng, không để chung hồ sơ.

Thiết bị bệnh viện đi kèm có mã và người chịu trách nhiệm.

6.13. Bước 13 - Thông báo người bệnh/người đại diện

Giải thích lý do, nơi đến, người phụ trách và dự kiến quá trình.

Hướng dẫn mang đồ cần thiết và không tự rời phương tiện.

Bảo đảm quyền riêng tư, ngôn ngữ dễ hiểu và hỗ trợ phiên dịch khi cần.

Không làm người bệnh hoang mang bằng thông tin chưa được xác nhận.

6.14. Bước 14 - Chọn phương tiện vận chuyển

Xe lăn cho người bệnh đủ khả năng ngồi và không có nguy cơ mất ổn định.

Cáng/giường cho người bệnh không tự đi, nguy cơ ngã, có thiết bị hoặc cần nằm.

Phương tiện chuyên dụng cho trẻ sơ sinh, người bệnh nguy kịch, béo, cách ly hoặc chấn thương.

Kiểm tra phanh, lan can, dây đai, bánh xe và vệ sinh.

6.15. Bước 15 - Chuẩn bị thiết bị và nguồn dự phòng

Kiểm tra monitor, máy thở, bơm tiêm điện, máy hút và thiết bị theo dõi.

Kiểm tra pin và nguồn điện dự phòng.

Tính lượng oxy và thuốc/dịch đủ cho thời gian dự kiến cộng dự phòng.

Thiết bị lỗi phải thay trước chuyển.

6.16. Bước 16 - Bố trí đội hộ tống

Căn cứ mức nguy cơ, chuyên khoa và can thiệp có thể cần trên đường.

Xác định trưởng nhóm và người phụ trách đường thở, thuốc, thiết bị khi nguy kịch.

Nhân viên hộ tống phải có năng lực sử dụng thiết bị và xử trí tình huống dự kiến.

Không giao người bệnh nguy cơ cao cho nhân viên vận chuyển đơn độc.

6.17. Bước 17 - Thực hiện 'dừng kiểm tra' trước rời khoa

Đọc to: đúng người bệnh, đúng khoa đến, mức nguy cơ, dị ứng/cách ly.

Kiểm tra đường thở, oxy, đường truyền, dẫn lưu, thiết bị, phanh/lan can.

Kiểm tra hồ sơ, thuốc, mẫu, tài sản và người hộ tống.

Mọi thành viên xác nhận sẵn sàng; chưa đạt phải khắc phục.

6.18. Bước 18 - Chuyển người bệnh lên phương tiện

Khóa giường/cáng và dùng kỹ thuật chuyển tư thế an toàn.

Đủ số người hỗ trợ; bảo vệ cột sống, vùng mổ, dẫn lưu và da.

Đặt dây/ống gọn, quan sát được và không nằm dưới người bệnh.

Che chắn, giữ ấm và bảo đảm riêng tư.

6.19. Bước 19 - Rời khoa và thông báo thời điểm

Khoa giao ghi giờ rời khoa.

Thông báo khoa nhận nếu thời gian thay đổi hoặc có trì hoãn.

Mang theo số liên lạc cần thiết.

Không dừng ở khu vực không liên quan hoặc để người bệnh không giám sát.

6.20. Bước 20 - Theo dõi trong vận chuyển

Theo dõi tri giác, đường thở, hô hấp, tuần hoàn và đau theo mức nguy cơ.

Quan sát oxy, monitor, truyền dịch, bơm tiêm, ống và dẫn lưu.

Ghi diễn biến/can thiệp đối với người bệnh nguy cơ cao hoặc khi có bất thường.

Duy trì phòng ngừa ngã, cách ly và bảo mật.

6.21. Bước 21 - Xử trí diễn biến xấu trên đường

Dừng tại vị trí an toàn, đánh giá và can thiệp trong phạm vi.

Gọi hỗ trợ cấp cứu và thông báo khoa nhận/khoa giao.

Chuyển đến điểm cấp cứu gần nhất nếu cần theo kế hoạch bệnh viện.

Ghi thời điểm, diễn biến, can thiệp và người được thông báo.

6.22. Bước 22 - Xác nhận đúng khoa và vị trí tiếp nhận

Đối chiếu tên khoa, giường/ô tiếp nhận và người nhận.

Không để người bệnh tại hành lang hoặc khu không có nhân viên nhận.

Người bệnh cách ly đi đúng khu vực đã chuẩn bị.

Nếu khoa chưa sẵn sàng, đội hộ tống tiếp tục chịu trách nhiệm chăm sóc.

6.23. Bước 23 - Đối chiếu nhận diện tại khoa nhận

Khoa giao và khoa nhận cùng xác nhận ít nhất hai thông tin.

Đối chiếu vòng tay, hồ sơ và nhãn thuốc/mẫu.

Trẻ sơ sinh đối chiếu vòng và thông tin mẹ theo quy định.

Khi có sai khác nhận diện, cùng xác minh ngay và ghi cách xử lý; không chuyển trách nhiệm bằng thông tin chưa được làm rõ. Khoa nhận vẫn phối hợp đánh giá, cấp cứu và giám sát người bệnh trong lúc xác minh.

6.24. Bước 24 - Bàn giao trực tiếp theo SBAR

S: lý do chuyển, tình trạng hiện tại, mức nguy cơ và vấn đề cấp bách.

B: chẩn đoán, bệnh nền, dị ứng, diễn biến, phẫu thuật/thủ thuật và cách ly.

A: dấu hiệu sinh tồn, tri giác, đau, đường thở, thuốc/dịch, đường truyền, dẫn lưu và đánh giá điều dưỡng.

R: việc cần làm ngay, thuốc/liều tiếp theo, theo dõi, kết quả chờ, nguy cơ và tiêu chí báo bác sĩ.

Thông tin phải ngắn gọn nhưng đủ để khoa nhận chăm sóc an toàn.

6.25. Bước 25 - Bàn giao thuốc, thiết bị, hồ sơ và tài sản

Kiểm đếm trực tiếp từng thuốc đang truyền, bơm, thiết bị và đường ống.

Bàn giao hồ sơ, kết quả, mẫu bệnh phẩm và phiếu chuyên khoa.

Bàn giao tài sản cho người bệnh, người đại diện hoặc đơn vị nhận theo phiếu; ghi đúng người nhận và số lượng.

Khoa nhận xác nhận số lượng và tình trạng.

6.26. Bước 26 - Hỏi đáp và đọc lại

Người nhận đặt câu hỏi về nội dung chưa rõ.

Đọc lại thông tin trọng yếu: dị ứng, thuốc nguy cơ cao, liều tiếp, oxy, đường thở, cảnh báo và việc cần làm ngay.

Người giao xác nhận hoặc sửa sai.

Làm rõ bất đồng trọng yếu ngay với bác sĩ hoặc người phụ trách; không ký xác nhận nội dung chưa kiểm chứng. Người nhận phối hợp chăm sóc ngay, ghi nhận phần đã tiếp nhận, phần còn chờ, người giải quyết và thời hạn; không để tranh chấp giấy tờ trì hoãn cấp cứu.

6.27. Bước 27 - Đánh giá ban đầu của khoa nhận

Đánh giá nhanh ABC, tri giác, dấu hiệu sinh tồn, đau và vị trí thiết bị.

Kiểm tra da, băng, đường truyền, dẫn lưu, oxy và thuốc đang chạy.

Xác nhận giường, lan can, chuông gọi, cách ly và thiết bị.

Báo bác sĩ ngay khi tình trạng khác thông tin bàn giao hoặc có bất thường.

6.28. Bước 28 - Xác nhận chuyển trách nhiệm

Người giao và người nhận ghi họ tên, chức danh, thời gian và ký/xác nhận điện tử.

Thời điểm trách nhiệm chuyển là khi khoa nhận xác nhận đã tiếp nhận.

Nội dung còn thiếu phải ghi người bổ sung và thời hạn.

Khoa giao không rời đi trước khi tiếp nhận hoàn tất đối với người bệnh nguy cơ cao.

6.29. Bước 29 - Cập nhật hệ thống và kết thúc tại khoa giao

Cập nhật trạng thái chuyển khoa, giường, thuốc và hồ sơ điện tử.

Bàn giao giường cũ, tài sản khoa và vệ sinh môi trường.

Theo dõi kết quả còn chờ theo phân công; thông báo khoa nhận khi có kết quả.

Lưu bản phiếu/biên nhận theo quy định.

6.30. Bước 30 - Lập kế hoạch tiếp tục tại khoa nhận

Tiếp nhận y lệnh, phân cấp chăm sóc và phân công điều dưỡng.

Lập/điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, thuốc, dinh dưỡng, cách ly và theo dõi.

Thông báo người bệnh/người đại diện về khoa, người phụ trách và bước tiếp theo.

Ghi nhận mọi sai lệch bàn giao và báo sự cố khi cần.

6.31. Bước 31 - Bàn giao khi chuyển tạm thời làm kỹ thuật

Khoa điều trị bàn giao mục đích, chuẩn bị, thuốc, dị ứng, nguy cơ và điều kiện theo dõi.

Đơn vị kỹ thuật xác nhận tiếp nhận và chịu trách nhiệm trong thời gian thực hiện.

Sau kỹ thuật, bàn giao lại tình trạng, can thiệp, thuốc, biến cố, kết quả sơ bộ và hướng dẫn.

Không trả người bệnh về khoa khi chưa có người nhận.

6.32. Bước 32 - Bàn giao Phòng mổ/Hồi tỉnh

Trước mổ: xác nhận người bệnh, thủ thuật/vị trí, nhịn ăn, dị ứng, hồ sơ, máu, thuốc và thiết bị.

Sau mổ/Hồi tỉnh: bàn giao loại phẫu thuật, gây mê, đường thở, mất máu, dịch/thuốc, đau, dẫn lưu, biến cố và kế hoạch.

Chỉ chuyển khỏi Hồi tỉnh khi đạt tiêu chí của bệnh viện hoặc có quyết định chuyên môn.

Người bệnh chưa đạt tiêu chí phải được bàn giao mức nguy cơ tương ứng.

6.33. Bước 33 - Bàn giao người bệnh hồi sức/nguy kịch

Bác sĩ - bác sĩ và điều dưỡng - điều dưỡng bàn giao trực tiếp.

Duy trì monitor, máy thở, thuốc vận mạch và hỗ trợ sống trong suốt quá trình.

Khoa nhận chuẩn bị sẵn giường, máy, oxy, hút và đội tiếp nhận.

Bàn giao thông số cài đặt, mục tiêu sinh lý, xu hướng và kế hoạch dự phòng.

6.34. Bước 34 - Kết thúc quy trình

Xác nhận người bệnh an toàn, khoa nhận đã nhận đầy đủ và hồ sơ hoàn tất.

Vệ sinh/khử khuẩn phương tiện và thiết bị theo quy định.

Bổ sung vật tư, oxy, pin và thuốc cho lần sau.

Báo cáo bàn giao không hoàn chỉnh, chậm tiếp nhận, nhầm người, tuột thiết bị hoặc diễn biến trên đường.

Đánh giá hành động khắc phục và chia sẻ bài học an toàn.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN, SỰ CỐ

7.1. Tai biến trong khi chuẩn bị và vận chuyển

Tình trạng người bệnh xấu đi trước rời khoa: dừng chuyển, đánh giá/cấp cứu, báo bác sĩ và khoa nhận; lập lại kế hoạch khi ổn định.

Ngừng thở, ngừng tuần hoàn hoặc suy hô hấp trên đường: kích hoạt cấp cứu, hồi sức theo quy trình và chuyển đến điểm phù hợp gần nhất.

Tuột/rò đường truyền, ống thở, dẫn lưu hoặc thiết bị: dừng an toàn, xử trí trong phạm vi, gọi hỗ trợ và ghi nhận.

Hết oxy, hết pin hoặc lỗi thiết bị: chuyển sang nguồn dự phòng; báo sự cố thiết bị và rà soát chuẩn bị.

Ngã, trượt hoặc chấn thương khi chuyển: không di chuyển thêm khi chưa đánh giá, cấp cứu và báo sự cố.

Kích động/bạo lực: bảo đảm khoảng cách an toàn, gọi hỗ trợ chuyên môn/an ninh, tránh kích thích thêm và xử trí theo quy trình.

Phơi nhiễm sinh học: sơ cứu và kích hoạt quy trình phơi nhiễm nghề nghiệp.

7.2. Tai biến/sự cố tại thời điểm bàn giao

Sai người bệnh/sai khoa: dừng ngay, bảo đảm người bệnh an toàn, thông báo lãnh đạo và báo sự cố nhận diện.

Khoa nhận từ chối hoặc chưa sẵn sàng: đội giao tiếp tục chăm sóc, liên hệ điều phối; không bỏ người bệnh tại hành lang.

Thiếu hồ sơ, thuốc, thiết bị hoặc tài sản: ghi thiếu, xác định người bổ sung và thời hạn; ưu tiên nội dung ảnh hưởng chăm sóc ngay.

Thông tin không thống nhất: kiểm tra hồ sơ/y lệnh, liên hệ bác sĩ hoặc người ra quyết định; dùng đọc lại để chốt.

Thuốc đang truyền không nhãn hoặc không khớp: đánh giá người bệnh, báo bác sĩ ngay, đối chiếu y lệnh và chuẩn bị thuốc hoặc hệ thống truyền đã xác minh. Bác sĩ quyết định tiếp tục, thay thế hoặc ngừng theo nguy cơ; không tự ngắt đột ngột thuốc vận mạch hay thuốc hỗ trợ sống. Khi nghi phản ứng thuốc đe dọa tính mạng, xử trí ngay theo quy trình cấp cứu tương ứng và báo sự cố.

Kết quả nguy kịch chưa được báo: thông báo trực tiếp bác sĩ/khoa nhận, ghi thời điểm và xác nhận đã nhận.

7.3. Sự cố sau bàn giao

Phát hiện bỏ sót dị ứng, thuốc, chỉ định, xét nghiệm hoặc nguy cơ: khắc phục ngay, thông báo người liên quan và đánh giá ảnh hưởng.

Mất hồ sơ, mẫu bệnh phẩm hoặc tài sản: truy vết tuyến chuyển, niêm phong dữ liệu liên quan và lập biên bản.

Sai lệch thiết bị/đường ống: đánh giá người bệnh, sửa nhãn/cấu hình và báo sự cố.

Người bệnh đến sai giường hoặc sai chế độ cách ly: chuyển đến vị trí đúng bằng biện pháp an toàn và xử lý môi trường khi cần.

Bàn giao chưa có chữ ký/xác nhận: hoàn thiện ngay; nếu không xác định người nhận, báo điều dưỡng trưởng/trực lãnh đạo.

Không quy kết cá nhân trước khi phân tích hệ thống, khối lượng công việc, biểu mẫu, công nghệ và điều phối.

7.4. Biến chứng muộn

Chậm thuốc, chậm xét nghiệm, chậm can thiệp hoặc diễn biến do thông tin bàn giao thiếu: điều trị kịp thời, báo sự cố và phân tích nguyên nhân.

Nhiễm khuẩn do sai cách ly hoặc vệ sinh phương tiện: báo KSNK, đánh giá người tiếp xúc và triển khai biện pháp.

Tổn thương da, loét tỳ đè hoặc đau tăng sau vận chuyển: đánh giá, chăm sóc và điều chỉnh phương tiện/kỹ thuật.

Sự cố lặp lại cùng điểm chuyển: thực hiện phân tích chuyên đề và sửa quy trình/biểu mẫu/hệ thống.

Thông tin cho người bệnh/người đại diện về sự cố thực hiện theo quy định bệnh viện và pháp luật.

7.5. Giám sát và cải tiến

Theo dõi tỷ lệ bàn giao đủ SBAR, đủ hai thông tin nhận diện, đúng thời gian và có xác nhận người nhận.

Theo dõi chậm chuyển, từ chối tiếp nhận, thiếu hồ sơ/thuốc, diễn biến trên đường, tuột thiết bị và nhầm người.

Kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ, quan sát trực tiếp và phỏng vấn người giao/nhận.

Đánh giá năng lực nhân viên khi tuyển dụng, định kỳ và sau sự cố.

Rà soát phân tầng nguy cơ, thiết bị, nguồn oxy, pin, tuyến vận chuyển và biểu mẫu.

Thử nghiệm giải pháp điện tử phải vẫn bảo đảm giao tiếp hai chiều và cơ hội hỏi đáp.

TÀI LIỆU. THAM KHẢO

1. Quốc hội. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023.

2. Chính phủ. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

3. Bộ Y tế. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.

4. Bộ Y tế. Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng phần còn hiệu lực và biểu mẫu hiện hành. Văn bản đã hết hiệu lực một phần.

5. World Health Organization. Communication During Patient Hand-Overs. Patient Safety Solutions, Volume 1, Solution 3. 2007.

6. World Health Organization. Transitions of Care: Technical Series on Safer Primary Care. 2016.

7. World Health Organization. Medication Safety in Transitions of Care. 2019.

8. World Health Organization. Patient Identification. Patient Safety Solutions, Volume 1, Solution 2. 2007.

9. Các quy định về nhận diện người bệnh, quản lý thuốc, vận chuyển nội viện, hồ sơ bệnh án, cách ly và quản lý tài sản hiện hành của BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN.

10. Bộ Y tế. Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương và thể thức quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; dùng để chuẩn hóa cấu trúc 7 phần và các mục chuẩn bị 5.1–5.9 theo yêu cầu của bệnh viện. Phân tầng vận chuyển 3 mức trong tài liệu là đề xuất nội bộ, không phải tiêu chí do QĐ 3023 quy định.

11. Bộ Y tế. Thông tư 13/2025/TT-BYT ngày 06/06/2025 hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Khi hệ thống gián đoạn, dùng biểu mẫu dự phòng được phê duyệt, ghi thời điểm và người thực hiện, đối chiếu khi cập nhật lại; không dùng chung tài khoản hoặc ghi lùi giờ.

Nguồn đối chiếu: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=178219 ; https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=167907 ; https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/research/patient-safety-solutions . Ngày rà soát: 13/10/2026.

Trước ban hành, Phòng Điều dưỡng xác nhận mã QT.PĐD.10, người ký, ngày hiệu lực, tiêu chí phân tầng theo chuyên khoa, số gọi cấp cứu và đầu mối điều phối của Nhật Tân. Không áp dụng phân tầng, mục tiêu hoặc tần suất của dự thảo như quy định đã phê duyệt.

PHỤ LỤC. DANH MỤC BIỂU MẪU

PL.01 - Ma trận phân tầng nguy cơ vận chuyển và yêu cầu hộ tống.

PL.02 - Phiếu bàn giao người bệnh theo SBAR.

PL.03 - Bảng kiểm trước khi rời khoa.

PL.04 - Phiếu bàn giao thuốc, dịch truyền, đường ống, thiết bị và tài sản.

PL.05 - Bảng kiểm tiếp nhận người bệnh từ Khám bệnh/Cấp cứu vào khoa nội trú.

PL.06 - Bảng kiểm bàn giao Phòng mổ - Hồi tỉnh - khoa điều trị.

PL.07 - Bảng kiểm người bệnh cách ly/nguy cơ cao.

PL.08 - Phiếu xác nhận tiếp nhận và bàn giao người bệnh.

PL.09 - Phiếu sự cố bàn giao và kế hoạch khắc phục.

PL.10 - Bảng đánh giá năng lực và bộ chỉ số giám sát.

PL.01
MA TRẬN PHÂN TẦNG NGUY CƠ VẬN CHUYỂN VÀ YÊU CẦU HỘ TỐNG

Mức	Tiêu chí gợi ý	Phương tiện	Người hộ tống	Yêu cầu bổ sung
Mức 1 - Ổn định	Dấu hiệu ổn định; không cần hỗ trợ sống hoặc theo dõi liên tục	Xe lăn/cáng/giường phù hợp	Nhân viên vận chuyển hoặc điều dưỡng theo đánh giá	Hồ sơ, chuông/liên lạc, phòng ngừa ngã
Mức 2 - Có nguy cơ	Oxy, truyền dịch/thuốc; nguy cơ diễn biến, co giật, ngã; sau thủ thuật	Cáng/giường, oxy, monitor theo chỉ định	Điều dưỡng/hộ sinh có năng lực; bác sĩ khi chỉ định	Thuốc/vật tư cấp cứu, nguồn dự phòng
Mức 3 - Nguy kịch	Đường thở nhân tạo, thở máy, thuốc vận mạch, huyết động không ổn định hoặc nguy cơ ngừng tuần hoàn	Giường/cáng hồi sức, monitor, máy thở, oxy, hút, bơm	Bác sĩ + điều dưỡng; đội hỗ trợ theo tình trạng	Hồi sức liên tục, khoa nhận sẵn sàng cấp cứu

Mức nguy cơ của bệnh viện: □ Mức 1 □ Mức 2 □ Mức 3

Lý do/phân tầng: ……

Người phê duyệt chuyển: …… Thời điểm: ……

Ma trận là khung quản trị nội bộ; bệnh viện cần phê duyệt tiêu chí chi tiết theo chuyên khoa, nguồn lực và năng lực nhân viên.

PL.02

PHIẾU BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH THEO SBAR

Họ tên người bệnh: …… Mã hồ sơ: ……

Ngày sinh: …… Khoa giao: …… Khoa nhận: ……

Thời điểm bàn giao: …… Mức nguy cơ: □ 1 □ 2 □ 3

Thành phần	Nội dung tối thiểu	Thông tin bàn giao
S - Tình huống	Lý do chuyển; chẩn đoán chính; tình trạng hiện tại; vấn đề cấp bách; cách ly.	
B - Thông tin nền	Bệnh nền; dị ứng; diễn biến; phẫu thuật/thủ thuật; thuốc quan trọng; tiền sử liên quan.	
A - Nhận định	Dấu hiệu sinh tồn; tri giác; đau; đường thở; oxy; thuốc/dịch đang truyền; đường truyền; dẫn lưu; da; nguy cơ.	
R - Khuyến nghị	Việc cần làm ngay; liều thuốc tiếp; mục tiêu theo dõi; xét nghiệm chờ; tiêu chí báo bác sĩ; kế hoạch dự phòng.	

Kết quả đang chờ/người theo dõi: ……

Thông tin đã đọc lại: □ Dị ứng □ Thuốc/liều tiếp □ Oxy/đường thở □ Cảnh báo

Câu hỏi/nội dung cần làm rõ: ……

PL.03
BẢNG KIỂM TRƯỚC KHI RỜI KHOA

STT	Nội dung	Đạt	Không đạt	Không áp dụng	Ghi chú
1	Có quyết định chuyển và khoa đến.	□	□	□	
2	Khoa nhận đã xác nhận sẵn sàng.	□	□	□	
3	Đúng người bệnh bằng ít nhất hai thông tin.	□	□	□	
4	Đã đánh giá dấu hiệu sinh tồn và tình trạng hiện tại.	□	□	□	
5	Đã phân tầng nguy cơ vận chuyển.	□	□	□	
6	Đã ổn định tối đa có thể.	□	□	□	
7	Yêu cầu cách ly/an ninh đã xác định.	□	□	□	
8	Dị ứng/cảnh báo đã ghi rõ.	□	□	□	
9	Thuốc đang dùng và liều kế tiếp đã đối chiếu.	□	□	□	
10	Oxy đủ và có dự phòng.	□	□	□	
11	Pin thiết bị đủ và có dự phòng.	□	□	□	
12	Đường truyền/ống/dẫn lưu đã kiểm đếm, cố định.	□	□	□	
13	Phương tiện vận chuyển an toàn.	□	□	□	
14	Người hộ tống đúng mức nguy cơ.	□	□	□	
15	Hồ sơ/kết quả/chỉ định đầy đủ.	□	□	□	
16	Kết quả đang chờ và người theo dõi rõ.	□	□	□	
17	Thuốc, mẫu bệnh phẩm và tài sản đã nhận diện.	□	□	□	
18	Người bệnh/người đại diện đã được thông báo.	□	□	□	
19	Đã thực hiện dừng kiểm tra trước chuyển.	□	□	□	
20	Khoa nhận được cập nhật nếu tình trạng thay đổi.	□	□	□	

PL.04
PHIẾU BÀN GIAO THUỐC, DỊCH TRUYỀN, ĐƯỜNG ỐNG, THIẾT BỊ VÀ TÀI SẢN

A. THUỐC VÀ DỊCH TRUYỀN

STT	Tên thuốc/dịch	Nồng độ	Tốc độ	Giờ bắt đầu	Liều/giờ tiếp	Người kiểm tra	Ghi chú
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B. ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ

STT	Loại/vị trí	Ngày đặt	Thông số	Tình trạng	Lượng dịch	Người nhận	Ghi chú
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

C. TÀI SẢN, THUỐC CÁ NHÂN VÀ MẪU BỆNH PHẨM

STT	Nội dung	Số lượng	Niêm phong/mã	Người giao	Người nhận	Ghi chú
1						
2						
3						
4						
5						
6						

PL.05
BẢNG KIỂM TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH TỪ KHÁM BỆNH/CẤP CỨU VÀO KHOA NỘI TRÚ

STT	Nội dung	Đạt	Không đạt	Không áp dụng	Ghi chú
1	Quyết định nhập viện và khoa/giường rõ.	□	□	□	
2	Đã xác nhận hai thông tin nhận diện.	□	□	□	
3	Chẩn đoán sơ bộ/chính và lý do nhập viện rõ.	□	□	□	
4	Dấu hiệu sinh tồn và tri giác mới nhất.	□	□	□	
5	Đã phân cấp chăm sóc và nguy cơ ngã/loét.	□	□	□	
6	Dị ứng và cảnh báo đặc biệt rõ.	□	□	□	
7	Thuốc đã dùng tại Khám bệnh/Cấp cứu đầy đủ thời điểm.	□	□	□	
8	Thuốc/liều tiếp theo được xác định.	□	□	□	
9	Đường truyền, oxy, ống và dẫn lưu được kiểm đếm.	□	□	□	
10	Xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh đã có được bàn giao.	□	□	□	
11	Kết quả đang chờ và người theo dõi rõ.	□	□	□	
12	Chế độ cách ly/nhiễm khuẩn rõ.	□	□	□	
13	Tài sản/thuốc cá nhân được bàn giao.	□	□	□	
14	Người bệnh/người đại diện được thông báo.	□	□	□	
15	Điều dưỡng khoa nhận đã đánh giá ban đầu.	□	□	□	
16	Bác sĩ khoa nhận được báo khi có nguy cơ/bất thường.	□	□	□	
17	Hồ sơ điện tử/giấy đã truy cập được.	□	□	□	
18	Người giao và người nhận đã ký/xác nhận.	□	□	□	

PL.06

BẢNG KIỂM BÀN GIAO PHÒNG MỔ - HỒI TỈNH - KHOA ĐIỀU TRỊ

A. TRƯỚC PHẪU THUẬT/THỦ THUẬT

STT	Nội dung	Đạt	Không đạt	Không áp dụng	Ghi chú
1	Đúng người bệnh, đúng phẫu thuật/thủ thuật và vị trí.	□	□	□	
2	Hồ sơ, cam kết, hội chẩn và đánh giá tiền mê đầy đủ.	□	□	□	
3	Tình trạng nhịn ăn và chuẩn bị trước mổ rõ.	□	□	□	
4	Dị ứng, nhóm máu, máu dự trù và kháng sinh dự phòng rõ.	□	□	□	
5	Đường truyền, thuốc, oxy và thiết bị được bàn giao.	□	□	□	
6	Răng giả, trang sức, tài sản và đồ cá nhân được xử lý.	□	□	□	
7	Kết quả quan trọng và nguy cơ gây mê/phẫu thuật được báo.	□	□	□	
8	Người nhận Phòng mổ xác nhận.	□	□	□	

B. SAU PHẪU THUẬT/HỒI TỈNH

STT	Nội dung	Đạt	Không đạt	Không áp dụng	Ghi chú
1	Loại phẫu thuật/thủ thuật và phương pháp vô cảm.	□	□	□	
2	Đường thở, oxy/thở máy và tiêu chí theo dõi.	□	□	□	
3	Dấu hiệu sinh tồn và mức tỉnh táo khi chuyển.	□	□	□	
4	Mất máu, dịch vào/ra và truyền máu.	□	□	□	
5	Thuốc đã dùng, giảm đau và liều tiếp.	□	□	□	
6	Vết mổ, băng, dẫn lưu, catheter và tư thế.	□	□	□	
7	Biến cố trong mổ/hồi tỉnh và xử trí.	□	□	□	
8	Xét nghiệm/kết quả đang chờ.	□	□	□	
9	Chỉ định hậu phẫu, dinh dưỡng và vận động.	□	□	□	
10	Tiêu chí báo bác sĩ/chuyển hồi sức.	□	□	□	
11	Đạt tiêu chí ra Hồi tỉnh hoặc có quyết định chuyên môn.	□	□	□	
12	Khoa nhận đánh giá và ký nhận.	□	□	□	

PL.07
BẢNG KIỂM NGƯỜI BỆNH CÁCH LY/NGUY CƠ CAO

STT	Nội dung	Đạt	Không đạt	Không áp dụng	Ghi chú
1	Đường lây truyền/chế độ cách ly đã xác định.	□	□	□	
2	Khoa nhận và vận chuyển được thông báo.	□	□	□	
3	Người bệnh mang khẩu trang/phương tiện phù hợp.	□	□	□	
4	Đội hộ tống có PPE đúng.	□	□	□	
5	Tuyến vận chuyển và thang máy đã chuẩn bị.	□	□	□	
6	Phương tiện có thể vệ sinh/khử khuẩn.	□	□	□	
7	Hạn chế người đi cùng.	□	□	□	
8	Vật dụng/hồ sơ được bao gói đúng.	□	□	□	
9	Nguy cơ hành vi/an ninh đã đánh giá.	□	□	□	
10	Nguy cơ ngã/co giật/tự rút ống đã kiểm soát.	□	□	□	
11	Oxy, pin, thuốc và thiết bị đủ dự phòng.	□	□	□	
12	Khoa nhận có phòng/giường và thiết bị sẵn.	□	□	□	
13	Vệ sinh phương tiện sau chuyển.	□	□	□	
14	Phơi nhiễm/sự cố được báo cáo.	□	□	□	

PL.08

PHIẾU XÁC NHẬN TIẾP NHẬN VÀ BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH

Họ tên người bệnh: …… Mã hồ sơ: ……

Khoa giao: …… Khoa nhận: ……

Giờ rời khoa giao: …… Giờ đến khoa nhận: ……

STT	Nội dung xác nhận	Đã giao	Đã nhận	Người giao	Người nhận
1	**Người bệnh và nhận diện**	□	□		
2	**SBAR lâm sàng**	□	□		
3	**Thuốc/dịch truyền**	□	□		
4	**Đường ống/dẫn lưu**	□	□		
5	**Thiết bị**	□	□		
6	**Hồ sơ/kết quả**	□	□		
7	**Mẫu bệnh phẩm**	□	□		
8	**Tài sản/thuốc cá nhân**	□	□		
9	**Cách ly/cảnh báo**	□	□		
10	**Kết quả đang chờ**	□	□		

Tình trạng khi đến: ……

Nội dung còn thiếu/người bổ sung/hạn: ……

Thời điểm khoa nhận chính thức tiếp nhận trách nhiệm: ……

PL.09

PHIẾU SỰ CỐ BÀN GIAO VÀ KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC

1. Mã sự cố: …… Ngày/giờ: ……
2. Khoa giao/khoa nhận: ……
3. Loại sự cố: □ Sai người/sai khoa □ Thiếu thông tin □ Thiếu thuốc/hồ sơ □ Chậm tiếp nhận □ Diễn biến trên đường □ Tuột thiết bị □ Ngã □ Sai cách ly □ Khác
4. Mô tả diễn biến và ảnh hưởng: ……
5. Hành động ngay: ……
6. Người/đơn vị đã thông báo: ……
7. Nguyên nhân sơ bộ: ……
8. Đánh giá người bệnh và điều trị bổ sung: ……

STT	Hành động	Phụ trách	Thời hạn	Trạng thái	Kết quả	Bằng chứng hiệu lực
1						
2						
3						
4						
5						

PL.10
BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT

A. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Họ tên: …… Đơn vị: …… Ngày đánh giá: ……

Hình thức: ☐ Quan sát trực tiếp ☐ Mô phỏng ☐ Kiểm tra hồ sơ

STT	Nội dung	Đạt	Không đạt	Không áp dụng	Ghi chú
1	Xác nhận đúng quyết định và khoa nhận.	☐	☐	☐	
2	Nhận diện người bệnh bằng hai thông tin.	☐	☐	☐	
3	Đánh giá tình trạng và phân tầng nguy cơ.	☐	☐	☐	
4	Liên hệ, xác nhận khoa nhận.	☐	☐	☐	
5	Chuẩn bị phương tiện/thiết bị/oxy đúng.	☐	☐	☐	
6	Đối chiếu thuốc và kết quả đang chờ.	☐	☐	☐	
7	Kiểm đếm đường ống/dẫn lưu đúng.	☐	☐	☐	
8	Thực hiện dừng kiểm tra trước chuyển.	☐	☐	☐	
9	Theo dõi người bệnh trên đường đúng.	☐	☐	☐	
10	Xử trí diễn biến xấu đúng.	☐	☐	☐	
11	Bàn giao SBAR đầy đủ.	☐	☐	☐	
12	Thực hiện đọc lại thông tin trọng yếu.	☐	☐	☐	
13	Bàn giao hồ sơ/thuốc/tài sản đầy đủ.	☐	☐	☐	
14	Xác nhận thời điểm chuyển trách nhiệm.	☐	☐	☐	
15	Tuân thủ cách ly, riêng tư và bảo mật.	☐	☐	☐	
16	Báo cáo sự cố và khắc phục đúng.	☐	☐	☐	

Kết quả: ☐ Đạt độc lập ☐ Đạt có giám sát ☐ Chưa đạt

Nội dung đào tạo lại: …… Ngày đánh giá lại: ……

B. BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT

Chỉ số	Công thức/diễn giải	Tần suất	Mục tiêu	Kết quả
Tỷ lệ bàn giao có hai thông tin nhận diện	Số lượt đạt/Tổng lượt quan sát x 100	Tháng/quý		
Tỷ lệ bàn giao đủ SBAR	Số lượt bàn giao đủ các thành phần SBAR / tổng lượt bàn giao được kiểm tra × 100.	Tháng/quý		
Tỷ lệ có đọc lại thông tin trọng yếu	Số lượt đạt/Tổng lượt nguy cơ cao x 100	Quý		
Tỷ lệ khoa nhận xác nhận trước chuyển	Số lượt chuyển thông thường có xác nhận trước chuyển / tổng lượt chuyển thông thường được kiểm tra × 100; ca khẩn cấp theo dõi riêng.	Tháng		
Tỷ lệ phân tầng nguy cơ đầy đủ	Số phiếu có phân tầng/Tổng chuyển x 100	Tháng		

Chỉ số	Công thức/diễn giải	Tần suất	Mục tiêu	Kết quả
Tỷ lệ bảng kiểm trước chuyển đầy đủ	Số phiếu đủ/Tổng kiểm tra x 100	Tháng		
Thời gian chờ tiếp nhận	Phút từ khoa giao đề nghị tiếp nhận đến khoa nhận xác nhận sẵn sàng; báo trung vị và phân vị 90. Theo dõi riêng thời gian từ đến khoa nhận đến hoàn tất bàn giao.	Tháng		
Tỷ lệ hồ sơ/thuốc/thiết bị thiếu	Số lượt thiếu/Tổng chuyển x 100	Tháng		
Tỷ suất diễn biến xấu trong vận chuyển	Số lượt chuyển có diễn biến xấu / tổng lượt chuyển trong kỳ × 1.000; phân loại mức độ riêng.	Tháng/quý		
Số ngã/tuột đường ống khi chuyển	Tổng số và nguyên nhân	Quý		
Tỷ lệ kết quả chờ được theo dõi	Số kết quả đã trả được theo dõi và xử lý / tổng kết quả đã trả cần theo dõi trong kỳ × 100; kết quả chưa trả theo dõi riêng.	Quý		
Tỷ lệ nhân viên đạt năng lực	Số đạt/Tổng đánh giá x 100	Năm		
Tỷ lệ hành động khắc phục đúng hạn	Số đúng hạn/Tổng đến hạn x 100	Quý		
Mức hài lòng người bệnh về quá trình chuyển	Theo công cụ khảo sát được phê duyệt	Quý/năm		

Ghi chú sử dụng bộ chỉ số

Tần suất tháng, quý, năm và mục tiêu của PL.10 là đề xuất để bệnh viện phê duyệt. Khi kiểm tra, xác định cùng kỳ và cùng tập hợp cho tử số, mẫu số; không cộng số phiếu với số lượt thành một mẫu số. Mẫu số bằng 0 ghi không áp dụng; dữ liệu chưa có ghi chưa thu thập. Phân biệt số sự cố với số lượt chuyển có sự cố, không kết luận an toàn hơn chỉ vì số báo cáo giảm.